Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

# SENTENÇA

Autos 0803759-45.2018.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Aracelis de Freitas
Réu: Município de Paranaíba e outro

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Aracelis de Freitas em face do Município de Paranaíba - MS e Estado de Mato Grosso do Sul, todos qualificados nos autos, em que a autora objetiva a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos "Desve 100 mg", "Clonazepam 2 mg", "Clorpromazina 100 mg", "Risperidona 3 mg" e "Amato 100 mg", uma vez que é portadors das patologias compatíveis com o CID10 F.60.3 (Transtorno de personalidade com instabilidade emocional), F.31.5 (Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos), F.32.3 (Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), F.31 (Transtorno afetivo bipolar), F.30 (Episódio maníaco). Salientou que a demora no fornecimento dos referidos fármacos poderá agravar seu estado de saúde e que não dispõe de condição financeira para adquirir os referidos medicamentos sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela e juntou documentos.

Às f. 25, foi determinada a intimação do réu para se manifestar acerca do pedido de tutela antecipada, no prazo de 72 horas, bem como foi solicitado ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico do TJMS a emissão de parecer técnico sobre o caso.

O parecer técnico do N.A.T. encontra-se às f. 27/44.



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Devidamente notificado, o Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo indeferimento da liminar afirmando que para o pedido relativo ao fornecimento dos medicamentos Clonazepam e Desvenlafaxina existe tratamento alternativo na rede pública de saúde para a patologia da autora, bem como não há demonstração nos autos da ineficácia desse tratamento. No tocante ao Topiramato, embora esteja inserido na Rename, sua dispensação observa os termos do protocolo para epilepsia, não havendo comprovação da adequação da parte autora. Quanto aos demais medicamentos, afirmou que não há demonstração da recusa administrativa. Aduziu que as patologias não figuram risco de morte, não comprovada a urgência para concessão de liminar.

O Município veio aos autos sustentando a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, diante da ausência dos requisitos para a concessão do pedido liminar (f. 63/67).

Em Decisões Interlocutórias de f. 68/76, o pedido liminar foi parcialmente deferido.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 83/88, onde discorreu acerca da tese firmada pelo STJ com eficácia vinculante, da ausência de prova da imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, da imposição de sequestro de verba pública e da impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual. Requereu o julgamento improcedente do pedido autoral.

O Município de Paranaíba – MS deixou de apresentar contestação (f. 103).

A parte autora apresentou impugnação às f. 105/107.



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou à f. 113, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide à f. 114 e o Município de Paranaíba – MS quedou-se inerte (f. 117).

*É o relato. Decido.*

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Aracelis de Freitas, em face do Município de Paranaíba e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos.

Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão.

A doutrina explana o seguinte entendimento:

> *"(...) o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais (...)"* (Antônio Carlos Marcato *in* Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983)



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

> *"(...) Em verdade, no princípio da avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)"* (Rui Portanova *in* Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do Advogado, 2003. p. 218-219)

Corroborando os fragmentos doutrinários retro transcritos, colaciono o entendimento do e. TJMS, no seguinte aresto:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS AOS NECESSITADOS – OBRIGAÇÃO QUE É IMPOSTA A TODOS OS DEVEDORES, DE FORMA SOLIDÁRIA (...) cabe ao julgador avaliar as provas produzidas, sendo que se na visão do magistrado as provas apresentadas nos autos mostraram-se adequadas e suficientes, deve ser prestigiada a valoração do conjunto probatório e o livre convencimento motivado que lhe foi conferido, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. (...)"* (TJMS – AC 2011.019030-3. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, 3ª Turma Cível. Julgado em 19/07/2011) Grifei.

Dito isso, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Sustentam os réus, em síntese, não estarem presentes os requisitos necessários para compeli-los ao fornecimento dos medicamentos descritos na exordial.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT de f. 27/44 apresentou as seguintes conclusões:

> *"(...) Segundo laudo médico, a requerente é paciente do CAPS desde 2015, apresenta hipótese diagnóstica de Transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID10: F60.3), Transtorno afetivo bipolar episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos (CID10: F31.5), Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID10: F32.3), Transtorno afetivo bipolar (CID10: F31), Episódio maníaco (CID10: F30). Solicita os medicamentos Desvenlafaxina 100mg (Desve), Lamotrigina 100mg, Clonazepam 2mg, Clorpromazina 100mg, Risperidona 3mg, Topiramato 100mg (Amato) para o seu tratamento. Personalidade é definida pela totalidade dos traços emocionais e de comportamento de um indivíduo (caráter + temperamento). Pode-se dizer que é o jeito de ser da pessoa, o modo de sentir as emoções ou o jeito de agir. Em outras palavras, é o modo habitual, estável ao longo dos anos, de receber e processar os estímulos vindos do mundo e de devolver uma resposta (comportamento) ao meio externo. (...) O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um transtorno de humor caracterizado pela alternância de episódios de depressão, mania ou hipomania. É uma doença crônica que acarreta grande sofrimento, afetando negativamente a vida dos doentes em diversas áreas, em especial no trabalho, no lazer e nos relacionamentos interpessoais. O TAB resulta em prejuízo significativo e impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Indivíduos com TAB também demonstram aumentos significativos na utilização de serviços de saúde ao longo da vida se comparados a pessoas sem outras doenças Psiquiátricas. (...) A Depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

*podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. (...) O Desve (nome comercial) Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado (princípio ativo) é um inibidor da recaptação de serotonina (5-HT) e norepinefrina (NE), que não apresenta nenhuma atividade inibitória da monoaminoxidase (MAO), nenhuma afinidade por receptores muscarínicos colinérgicos, H1-histaminérgicos ou alfa1-Adrenérgicos. (...) A Lamotrigina (princípio ativo) é um antiepiléptico, da classe das feniltriazinas. Quimicamente, não é relacionada à outra droga antiepiléptica existente. O mecanismo de ação preciso, através do qual a Lamotrigina exerce sua ação anticonvulsivante, ainda não é conhecido. Um mecanismo de ação proposto envolve um efeito nos canais de sódio. (...) O Clonazepam (princípio ativo) pertence a uma família de remédios chamados benzodiazepínicos, que possuem como principais propriedades inibição leve de várias funções do sistema nervoso permitindo com isto uma ação anticonvulsivante, alguma sedação, relaxamento muscular e efeito tranquilizante. Em estudos feitos em animais o clonazepam foi capaz de inibir crises convulsivas de diferentes tipos, tanto por agir diretamente sobre o foco epiléptico como por impedir que este interfira na função do restante do sistema nervoso. (...) O Cloridrato de Clorpromazina (princípio ativo) que possui uma ação estabilizadora no sistema nervoso central e periférico e uma ação depressora seletiva sobre o SNC, permitindo, assim, o controle dos mais variados tipos de excitação. É, portanto, de grande valor no tratamento das perturbações mentais e emocionais. O Cloridrato de Clorpromazina tem propriedades neurolépticas, vagolíticas, simpatolíticas, sedativas e antieméticas. (...) A Risperidona (princípio ativo) é um antagonista seletivo das monoaminas cerebrais, com propriedades únicas. Ele tem uma alta afinidade pelos receptores serotoninérgicos 5HT2 e dopaminérgicos D2. Risperidona liga-se igualmente aos receptores alfa-1 adrenérgicos e, com menor afinidade, aos receptores histaminérgicos H1 e alfa-2 adrenérgicos. Risperidona não tem afinidade pelos receptores colinérgicos. Apesar de Risperidona ser um antagonista D2 potente, o que é considerado*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

*como ação responsável pela melhora dos sintomas positivos da esquizofrenia, o seu efeito depressor da atividade motora e indutor de catalepsia é menos potente do que os neurolépticos clássicos. (...) O Amato (nome comercial) Topiramato (princípio ativo) é um novo agente antiepiléptico, classificado como monossacarídeo sulfamato-substituído. Estudos eletrofisiológicos e bioquímicos em cultura de neurônios identificaram três propriedades que podem contribuir para a eficácia antiepiléptica do topiramato. Potenciais de ação provocados repetidamente pela despolarização contínua dos neurônios foram bloqueados pelo topiramato de maneira dependente do tempo, sugerindo uma ação bloqueadora do canal de sódio, efeito este conhecido como "bloqueio de canal dependente do estado" (na verdade, os canais não são bloqueados, mas sim, a frequência com que eles são reativados é que se apresenta diminuída). (...) A Desvenlafaxina 100mg, Clonazepam 2mg não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não constam no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009 ou outro ato normativo do SUS. Também não foram avaliadas pela CONITEC. A Lamotrigina, Risperidona estão padronizadas na RENAME, sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecidas através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I, Portaria SAS/MS nº 315, 30 de março de 2016. A Clorpromazina está padronizada na RENAME, sob o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), de responsabilidade dos municípios. O Topiramato está padronizado na RENAME, sob o CEAF, oferecido através de PCDT para Epilepsia, regido pela Portaria Conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018. (...) Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao Estado fornecer Lamotrigina 100mg, Risperidona 3mg através do PCDT do TAB (devendo a paciente permanecer cadastrada e renovando sua autorização), ao município fornecer Clorpromazina 100mg, e desfavorável ao pedido de Desvenlafaxina 100mg, Clonazepam 2mg, Topiramato 100mg."* (f. 27/44).



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou a possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento não padronizado na RENAME. Senão vejamos:

> *"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: <u>Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas</u>. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. <u>A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por</u>*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

> *meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."* (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Grifei.

No tocante aos medicamentos "Risperidona 3 mg" e "Clorpromazina 100 mg", o parecer técnico do NAT foi favorável ao pleito, de modo que o pedido deve ser acolhido neste ponto (f. 43).

Deve-se ressalvar, todavia, a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, o qual necessariamente contém o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Veja-se a jurisprudência:

> *"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESOBRIGAR O ENTE PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A ausência do medicamento na lista do SUS não impede o seu fornecimento pelo Estado, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade do requerente arcar com seu custo. Deve-se possibilitar ao ente público o fornecimento de medicamento de outro fornecedor além daquele indicado pelo médico desde que idêntico em sua composição, sem alterar, acrescer ou retirar componente, caso em que, por um lado, seria capaz de atingir*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

*a mesma finalidade e, por outro, prestigiar-se-ia o princípio da eficiência na gestão de recursos públicos. Faz-se necessária a apresentação e retenção da receita médica, preservando a integridade do tratamento médico, devidamente acompanhado."* (TJMG - Mandado de Segurança n. 092087-95.2012.8.13.00. Relator Desembargador Jair Varão. 3ª Câmara Cível. Julgado em 08.1.2012) Grifei.

*"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR GENÉRICO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).Saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II - O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Para alem disso, o Ministério da Saúde, através da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o medicamento de referência. Seu uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo contra-indicação a que possa substituir o medicamento de referência. (...)"* (TJRS - Apelação Cível Nº 70031710452, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 02/09/2009) Grifei.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se de forma inequívoca a presença das enfermidades indicadas na prefacial, razão pela qual a responsabilidade dos réus pelo fornecimento do produto necessário ao tratamento médico ao paciente que dele necessita é evidente, visto que garantido pela própria Constituição Federal.

Quanto ao tema, a doutrina assevera o seguinte entendimento:

> *"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais"* (José Afonso da Silva *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

A jurisprudência do c. STJ tem reconhecido a obrigação estatal de assegurar aos cidadãos o acesso à saúde, nos seguintes termos:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União,*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

*Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido."* (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 30/08/2007 p. 219) Grifei.

*"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Esta Corte em reiterados precedentes tem reconhecido a responsabilidade solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido."* (AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 11/06/2008) Grifei.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

*ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ARTIGO 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FORNECER MEDICAMENTO AOS NECESSITADOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ATESTADO MÉDICO INFORMANDO QUE A PARTE-AUTORA É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E QUE O MEDICAMENTO ISCOVER 75 MG É INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do artigo 196 da CF, há solidariedade na assistência à saúde pela União, pelo Estado e pelo Município, podendo a ação que tem por objeto o*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

*fornecimento de medicamento ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um. II. A existência de convênios entre a União, Estados e Municípios legitima a Fazenda Pública Estadual a exigir dos demais entes a sua participação nos gastos independentemente de determinação judicial ou de participação do referido ente no feito. III. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte-autora, bem como o medicamento indispensável para o tratamento da paciente, somando-se ao fato de que a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, a restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. IV. Não é possível a condenação do Estado, de suas autarquias e fundações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão entre credor e devedor. V. Recurso parcialmente provido.* (TJMS-3ªT., Proc. 2008.009815-7, Rel. Oswaldo Rodrigues de Melo, Jul. 05/05/2008) Grifei.

Quanto ao medicamento "Lamotrigina 100 mg", embora o NAT tenha sido favorável ao fornecimento do referido fármaco à autora, observo que na petição inicial foi informado que já está recebendo o medicamento (f. 03), razão pela qual não integrou o pedido inicial.

Por fim, quanto aos medicamentos "Desve 100 mg", "Clonazepam 2 mg" e "Amato 100 mg" tenho que, embora a médica ateste que a paciente fez uso anteriormente de outros medicamentos que não os pleiteados nesta ação, não há como se concluir pela ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS, um dos requisitos apresentados no julgamento do REsp nº 1.657.156.

Destarte, tendo em vista que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos três requisitos mencionados nesta fundamentação, o pleito autoral deve ser julgado improcedente neste ponto.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.

Vale anotar que, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (f. 114).

Ante todo o exposto, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na prefacial para o fim de CONDENAR o Município de Paranaíba e o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecerem à autora Aracelis de Freitas, gratuitamente, os fármacos denominados "Clorpromazina 100 mg", "Risperidona 3 mg", conforme prescrição médica, ressalvada a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, convalidando a decisão de f. 68/76.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Incabível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a reduzida complexidade e duração da demanda.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, 03 de julho de 2019.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
*Assinado digitalmente*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 04/07/2019 às 17:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803759-45.2018.8.12.0018 e código HmEi80xo.